

Faculté de médecine « IBN EL JAZZAR » de Sousse



Evaluation : Les Epilepsies

Adulte

Dr Anis Hassine
MCA-service de neurologie
CHU Sahloul- Sousse

Dr Khaoula Jemai
AHU-service de neurologie
CHU Sahloul Sousse

Cas clinique 1

Un homme âgé de 22 ans, n'ayant aucun antécédent particulier, consulte pour des épisodes paroxystiques de durée brève faites de contractions musculaires rythmées et régulières au niveau de l'hémicorps droit évoluant depuis quelques mois. Le patient rapporte qu'il n'a pas perdu le contact durant ces épisodes. L'examen neurologique était sans anomalies.

1. Il s'agit d'une crise épileptique devant:
 - A. La stéréotypie
 - B. La durée
 - C. Le début et le fin brusque
 - D. La normalité de l'examen neurologique
 - E. L'âge du patient
2. Il s'agit d'une :
 - A. Crise épileptique focale avec préservation de la conscience
 - B. Crise épileptique focale avec perte de la conscience
 - C. Crise épileptique focale avec sémiologie clinique observable
 - D. Crise épileptique généralisée
 - E. Crise inclassable
3. Quels sont les examens complémentaires que vous pouvez demander à visé étiologique:
 - A. Les enzymes musculaires (CPK-LDH)
 - B. Glycémie
 - C. Bilan toxicologique
 - D. TDM cérébrale
 - E. Calcémie

L'IRM cérébrale a montré la présence d'une dysplasie corticale gauche.

4. Quelle est votre conduite à tenir:
 - A. Instaurer un traitement anti épileptique de fond
 - B. Proscrire l'utilisation des ordinateurs et de télévision
 - C. Annoncer le diagnostic d'épilepsie maladie
 - D. Conseiller la patiente d'avoir une bonne hygiène de sommeil
 - E. Surveiller la patiente sans instaurer un traitement de fond

Cas clinique 2 :

Un étudiant de 21 ans, sans antécédents médicaux connus, présente brutalement en salle de sport une perte de connaissance avec révulsion oculaire, phase tonique de quelques secondes suivie de secousses cloniques bilatérales durant 90 secondes. À la récupération, il est confus, désorienté pendant 15 minutes, avec une morsure latérale de la langue. Pas d'incontinence observée.

1. Quels éléments cliniques sont en faveur d'une crise épileptique généralisée tonico-clonique ?
 - A. Début brutal avec perte de connaissance
 - B. Phase tonique puis clonique bilatérale
 - C. Réveil progressif avec confusion post-critique
 - D. Morsure latérale de la langue
 - E. Récupération immédiate sans confusion
2. Quels sont les diagnostics différentiels à évoquer ?
 - A. Syncope convulsivante
 - B. Crise non épileptique psychogène
 - C. Attaque de panique
 - D. Accident ischémique transitoire (AIT)
 - E. Migraine avec aura
3. Quelle est votre conduite à tenir ?
 - A. Reprendre un interrogatoire minutieux avec le patient et les témoins
 - B. Demander une imagerie cérébrale
 - C. Demander un électroencéphalogramme
 - D. Demander une radiographie du thorax
 - E. Passer un traitement antiépileptique par voie intraveineuse

Cas clinique 3 :

Un étudiant de 22 ans, sans antécédents, a présenté une perte brutale de connaissance en amphithéâtre. Les témoins décrivent une chute soudaine avec pâleur, perte de tonus, puis quelques secousses brèves des membres. L'épisode dure moins d'une minute. Le patient récupère rapidement, sans confusion post-critique, et dit avoir ressenti des vertiges et des nausées avant la chute.

1. Quels éléments orientent vers une syncope plutôt qu'une crise épileptique ?
 - A. Prodromes avec vertiges et nausées
 - B. Pâleur initiale
 - C. Perte de connaissance brutale avec chute
 - D. Secousses cloniques brèves pendant la perte de connaissance
 - E. Récupération rapide sans confusion
2. Quels éléments sont plutôt en faveur d'une crise épileptique généralisée ?
 - A. La révulsion des yeux
 - B. La Morsure au niveau du bout de la langue
 - C. La fuite urinaire
 - D. La confusion prolongée au réveil
 - E. Le retour progressif de la conscience normale

Cas clinique 4

Un homme âgé de 32 ans, épileptique connu mais non observant, est amené aux urgences pour une crise tonico-clonique généralisée qui dure depuis plus de 7 minutes. À son arrivée, il convulse toujours.

1. Quel est le diagnostic le plus probable ?
 - A. Crise tonico-clonique généralisée non compliquée
 - B. État de mal épileptique généralisée
 - C. Syncope
 - D. Crise épileptique focale avec bilatéralisation
 - E. Accident ischémique transitoire
2. Quelle est la prise en charge immédiate appropriée ?
 - A. Conditionnement du patient
 - B. Injection IV de clonazépam
 - C. Injections IV de phénobarbital
 - D. Intubation et anesthésie générale d'emblée
 - E. Attendre sans traitement car la crise peut s'arrêter spontanément

L'état de mal épileptique a été jugulé et le patient a été mis sortant sous traitement antiépileptique.

3. Quels sont vos recommandations à sa sortie :
 - A. Bonne hygiène de sommeil
 - B. Suivre un régime cétogène
 - C. Éviter les activités sportives
 - D. Ne pas regarder la télévision
 - E. Bonne observance thérapeutique

Cas clinique 5

Une femme âgée de 17 ans consulte pour une première crise épileptique tonico clonique généralisée. L'interrogatoire révèle des épisodes récidivants de secousses des 2 mains au réveil depuis l'âge de 15 ans. L'examen neurologique en post critique était normal.

1. Quel diagnostic suspectez-vous:
 - A. Epilepsie Absence
 - B. Syndrome de West
 - C. Epilepsie centro temporale
 - D. Epilepsie myoclonique juvénile
 - E. Epilepsie mésio temporale

2. Quel examen complémentaire allez vous demander pour confirmer votre diagnostic ?
 - A. Eléctroneuromyogramme
 - B. Eléctroencéphalogramme
 - C. Eléctrocardiogramme
 - D. Holter ECG
 - E. IRM cérébrale
3. Quels traitements pouvez-vous prescrire?
 - A. Valproate de Sodium
 - B. Phenobarbital
 - C. Lamotrigine
 - D. Carbamazepine
 - E. Leviteracetam

Cas clinique 6 :

Un garçon de 16 mois, sans antécédents particuliers, a présenté brutalement une perte de connaissance avec secousses tonico-cloniques généralisées durant environ 3 minutes, dans un contexte de fièvre à 39,5 °C. Il a récupéré rapidement, sans déficit post-critique. L'examen neurologique est normal après la crise.

1. Quel est le diagnostic le plus probable ?
 - A. Crise fébrile
 - B. Frissons
 - C. Épilepsie généralisée idiopathique
 - D. Méningite
 - E. Syncope hyperthermique
2. Quels critères définissent une crise fébrile simple dans ce cas ?
 - A. Durée
 - B. Crise généralisée
 - C. Répétition dans les 24 heures
 - D. Âge
 - E. Examen neurologique normal
3. Quelle est votre conduite à tenir dans ce cas ?
 - A. Traitement de la crise en urgence par du valium intra rectal
 - B. Antipyrétiques et traitement de la cause de la fièvre
 - C. Surveillance clinique et rassurer les parents
 - D. Mise en route d'un traitement antiépileptique au long cours
 - E. demander une IRM cérébrale

